

1) Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor torácico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Presenta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiograma: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

- a) Tratamiento anticoagulante
- b) Tratamiento antiplaquetario
- ☒ c) Solicitar AngioTAC de tórax
- d) Ecocardiograma bidimensional
- e) Coronariografía de urgencia

2) Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopia digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar prokinéticos
- b) Agregar antiácidos
- c) Duplicar la dosis de omeprazol -
- ☒ d) Erradicar Helicobacter Pylori
- e) Tratamiento quirúrgico

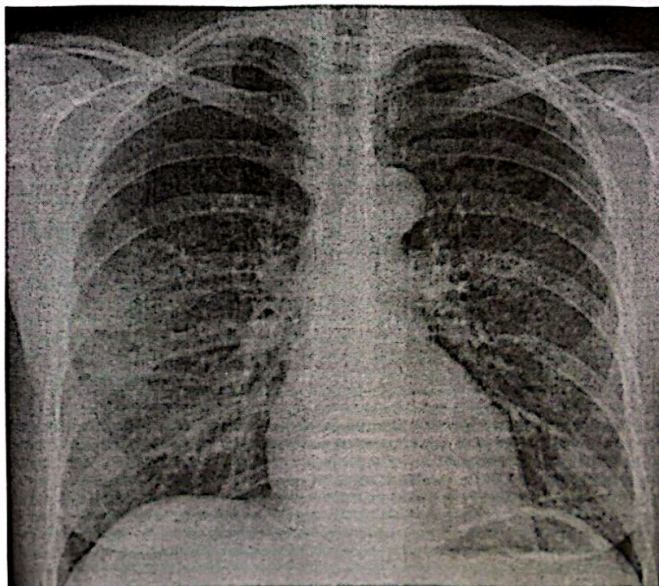
3) Una paciente de 28 años, consulta por artralgias generalizadas, asociadas a sensación febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina: 1,5 mg/dl, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 blancos por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Solicitar factor reumatoide
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa
- ☒ d) Solicitar anticuerpos antinucleares
- e) Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos.

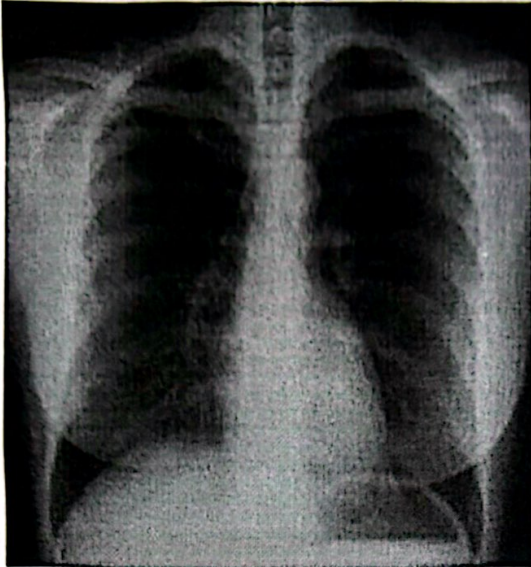
4) Un paciente de 35 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea importante. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 35 por minuto, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, presión arterial de 100/70mmHg y saturación de 93% con FiO₂ ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
- b) Bronquitis chlamydia trachomatis
- c) Tuberculosis pulmonar
- ☒ d) Neumonía por mycoplasma
- e) Neumonía por pneumocystis jiroveci



5) Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro anteroposterior torácico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación:



El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Salmeterol inhalado
- b) Ipratropio inhalado ☒
- c) Budesonida inhalado ☐
- d) Salbutamol inhalado ☐
- e) Tiotropio inhalado ☐

6) Una paciente de 48 años consulta por 2 meses de artralgias de las articulaciones de las manos, asociada a artralgias de tobillos, codos y pies. Además, tiene rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico tiene eritema y aumento de volumen en las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas proximales de manos y pies y del codo izquierdo. Su hemograma muestra Hcto: 38%, blancos: 5.900 por mm³, plaquetas: 230.000 por mm³, VHS: 46 mm/h y su PCR: 8 mg/dl (VN: menor a 1). Se solicita factor reumatoide que resulta: 240 UI/ml (VN: menor a 40 UI/ml) y anticuerpos anti-CCP que resultan: 112 UI (VN: menor a 20 UI). ¿Cuál es el fármaco de elección para modificar la progresión de la enfermedad?

- a) Prednisona ☒
- b) Naproxeno
- c) Hidroxicloroquina
- d) Azulfidina
- e) Metotrexato

7) Un paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión arterial y fumador, consulta por dolor torácico, siendo diagnosticado de un infarto agudo al miocardio, por lo que se hospitaliza para manejo. Al ingreso, presenta glicemia de 256 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 5,8%. Evoluciona con varias glicemias sobre 200 mg/dl, durante la hospitalización. ¿Cuál es la forma más adecuada de manejar sus glicemias?

- a) Metformina más glibenclamida con las comidas
- b) Sitagliptina
- c) Dieta ☒
- d) Insulina rápida cada 6 horas, endovenosa ☒
- e) Insulina NPH más insulina cristalina endovenosa con las comidas

8) Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitente. Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?

- a) Manometría esofágica
- b) Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
- c) Monitorización de pH esofágico de 24 horas
- d) TAC de abdomen y pelvis
- e) Ecografía abdominal

9) Un paciente de 44 años, consulta por dolor lumbar, de inicio súbito, irradiado por la cara posterior del muslo y la pierna derecha, de 2 días de evolución. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad del borde lateral del pie derecho, con ausencia del reflejo aquiliano y debilidad de la flexión plantar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Afectación de la raíz L5
- b) Síndrome facetario lateralizado
- c) Lesión del nervio ciático
- d) Afectación de la raíz S1
- e) Lesión del plexo lumbar

10) Una paciente de 94 años, hipertensa, es autovalente y tiene vida social activa. Acude a un control médico, siendo diagnosticada de fibrilación auricular, con FC: 80 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Antiagregantes
- b) Anticoagulantes
- c) Ecocardiografía transesofágica
- d) Ecocardiografía transtorácica
- e) Solicitar un electrocardiograma de 24 horas

11) Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dl, leucocitos 7.000 por mm³, plaquetas 230.000 por mm³, creatinina 0,8 mg/dl, calcio 11 mg/dl, albúmina 4 g/dl, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Mantener control ambulatorio anual
- b) Solicitar cintigrafía ósea
- c) Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
- d) Solicitar niveles de paratohormona
- e) Solicitar electroforesis de proteínas

12) Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

- a) Acrocordones
- b) Intértrigo candidiásico
- c) Impétigo buloso
- d) Tiña corporis
- e) Psoriasis

13) Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta, desde hace 24 horas, aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38°C, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Azitromicina
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico
- d) Acetaminofeno y salbutamol
- ☒ e) Cefadroxilo

14) Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm³ y plaquetas 10.000/mm³. El diagnóstico más probable es:

- ☒ a) Purpura trombocitopénico trombótico
- b) Hemofilia A
- c) Púrpura de Schönlein Henoch
- d) Purpura trombocitopénico inmune
- e) Enfermedad de Von Willebrand

15) Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, Blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

- ☒ a) Colitis ulcerosa ✓
- b) Giardiasis
- c) Divertículo de Meckel
- d) Colitis isquémica
- e) Enfermedad de Crohn ✓

16) Una paciente de 70 años consulta por dolor tipo urente en las extremidades inferiores, asociado a parestesias, descritas como "hormigueos" en los pies. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad en calcetín, con paresia a la extensión de los ortejos y disminución de ambos reflejos aquilianos. En cambio, los reflejos rotulianos se encuentran conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Radiculopatía S1 bilateral
- b) Síndrome de cauda equina
- c) Síndrome del cono medular
- d) Síndrome de Guillain Barré
- ☒ e) Polineuropatía

17) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante una paciente embarazada en el primer trimestre, que presenta una TSH de 4,5 UI/L?

- a) Iniciar propiltiouracilo
- b) Solicitar T4 libre
- ☒ c) Iniciar levotiroxina ✓
- d) Solicitar una nueva TSH en un mes
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea

2,5

18) Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por el que consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) ☒ Cáncer gástrico
- b) ☐ Úlcera gastroduodena
- c) ☐ Cáncer de esófago
- d) ☐ Linfoma gástrico, asociado a mucosa
- e) ☐ Gastritis erosiva

19) Un paciente de 38 años consulta por paresia facial bilateral, de una semana de evolución, mayor a izquierda. Además, presenta paresia del sexto nervio craneal izquierdo. Al examen físico tiene disminución generalizada de las fuerzas de las extremidades, con arreflexia e hipotonía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) ☐ Polineuropatía
- b) ☒ Síndrome de Guillain Barré
- c) ☐ Miastenia gravis
- d) ☐ Esclerosis múltiple
- e) ☐ Infarto de troncoencéfalo

20) Una mujer de 62 años, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociada a disnea. Al examen físico tiene pulso irregular, a 130 latidos por minuto, con PA: 110/70 mmHg. Su examen cardíaco muestra soplo diastólico III/VI, más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia-irregular, con complejos QRS angostos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) ☐ Administrar propanolol y antiagregantes
- b) ☐ Administrar enoxiheparina y verapamilo
- c) ☒ Administrar heparina y amiodraona
- d) ☐ Realizar cardioversión eléctrica
- e) ☐ Administrar adenosina y anticoagulantes orales

21) Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y glicemia poscarga de 139 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) ☒ Repetir la prueba de tolerancia a la glucosa a las 32 semanas
- b) ☐ Iniciar metformina
- c) ☐ Iniciar dieta hipoglucídica
- d) ☐ Iniciar insulina
- e) ☐ Mantener el control normal del embarazo

22) Una paciente de 20 años, en tratamiento con isotretinoína, desde hace 10 días, por acné, consulta por dolor abdominal, asociada a malestar general y astenia, a lo que se ha agregado ictericia y orinas oscuras. En su examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen se palpa bando, doloroso en epigastrio e hipocondrio, con hígado palpable 3 cm por debajo del reborde costal. Sus pruebas hepáticas resultan GOT: 328 UI/L, GPT: 459 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, FA: 80 UI/L, GGT: 92 UI/L, protrombinemia: 80%. Además, se solicita serología que muestra IgG(+)VHA, IgM(-)VHA, Antígeno VHBs(-), Anticuerpos totales antiHBV(+). Anticuerpos anti-VHC y marcadores de autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:

- a) ☐ Hepatitis A
 - b) ☐ Hepatitis B
 - c) ☒ Hepatitis C
 - d) ☐ Hepatitis por drogas
 - e) ☐ Hepatitis autoinmune
- ✓C yehus

23) Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2% y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

- a) Electroforesis de proteínas en sangre
- b) Biopsia renal
- c) Inmunofijación de proteínas en orina
- ☒ d) Prednisona oral
- e) ANCA, C3 y C4

prot. ✓
Edema ✓

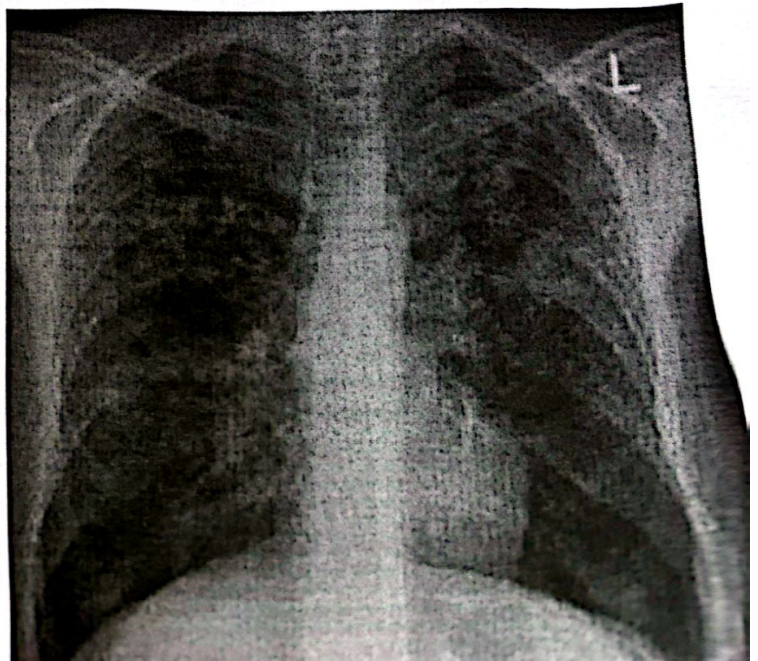
24) Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FIO₂ ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm³, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Biopsia pulmonar por videotoracoscopia
- ☒ b) Broncoscopia con biopsia pulmonar
- c) PET-TC
- d) Biopsia pleural por videotoracoscopia
- e) Broncoscopia con lavado bronquioalveolar

25) Un paciente de 35 años, en situación de calle, con antecedente poliadicciones, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido con peso 52 Kg, pálido, con edema de extremidades inferiores, T°: 37,2°C, FC: 87x', PA: 90/60 mmHg, FR: 15x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.000 por mm³, VHS: 50 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio?

- a) TAC de tórax
- b) Videotoracoscopia
- c) PPD
- ☒ d) Baciloscopías de expectoración
- e) Fibrobroncoscopia



26) Una paciente de 75 años, con historia de enfermedad de Alzheimer de 3 años de evolución, con buena funcionalidad presenta un cuadro en que agrede a otras personas y se muestra muy angustiada. Al examen físico le cuesta nombrar algunos objetos, no puede decir los días de la semana de manera invertida y se muestra poco atenta. Además, refiere que su padre ya fallecido está presente en la sala. Se hospitaliza para estudio y manejo y, al inicio, se muestra cooperadora y amable, pero luego exige que la dejen ir e intenta escapar del hospital y agredir al personal de salud. ¿Cuál es el fármaco inicial para el manejo de esta paciente?

- a) Clorpromazina
- b) Diazepam
- c) Mirtazapina
- d) Alprazolam
- e) Haloperidol

27) Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen especialmente luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicita un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 98% del valor esperado. Se solicita una radiografía, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

- a) Prick test ✓
- b) TAC de tórax
- c) Espirometría basal y postbroncodilatador ✓
- d) Prueba de eosinófilos nasales
- e) Prueba de provocación bronquial

28) Un paciente de 78 años, diabético, hipertenso y dislipidémico está en tratamiento con metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina. Se realiza exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,4 mEq/L, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?

- a) Nefroesclerosis hipertensiva -
- b) Uso de hidroclorotiazida -
- c) Nefropatía diabética -
- d) Uso de enalapril
- e) Uso de aspirina

3,3-5 potasio.

29) Un niño de 7 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 46 g/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

- a) Niveles plasmáticos de cortisol basal
- b) Insulinemia basal
- c) Creatinina plasmática
- d) Amilasemia
- e) Cetonemia

hipoglucemia
hiponatremia
hiperpotosmia

30) Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

- a) Estreptoquinasa
- b) Clopidogrel
- c) Nitroglicerina
- d) Atenolol
- e) Diazepam

31) Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis reactiva
- d) Condrocálcinosis
- e) Artrosis

bilateral

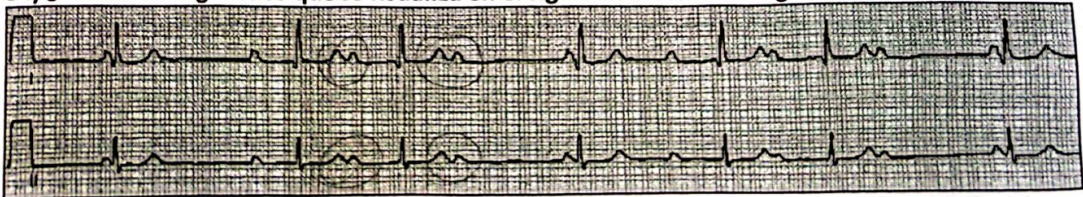
32) Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm³, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:

- a) Glomerulonefritis post estreptocócica
- b) Vasculitis de vasos pequeños
- c) Injuria renal pre renal
- d) Endocarditis infecciosa
- e) Nefritis intersticial

33) Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

- a) Psicometría
- b) Evaluación psicopedagógica
- c) Electroencefalograma
- d) TAC cerebral
- e) Audiometría

34) ¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?



- a) Bloqueo AV completo
- b) Fibrilación auricular lenta
- c) Bloqueo AV de 2do grado
- d) Bradicardia sinusal
- e) Paro sinusal

35) Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti-CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis reumatoidea
- b) Artritis reactiva
- c) Artrosis
- d) Artritis psoriática
- e) Síndrome de Sjögren primario

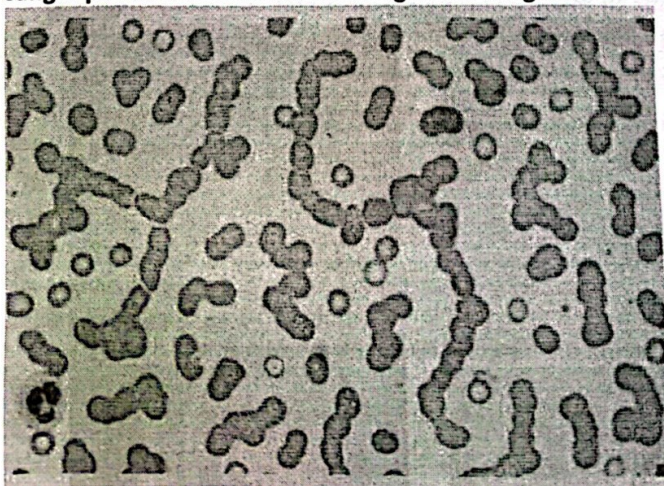
36) Un paciente indigente, en situación de calle, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de desorientación y dificultades para caminar. Al examen físico se constata estrabismo divergente, por parálisis del tercer nervio craneal izquierdo, ataxia de la marcha y desorientación temporoespacial, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Tuberculosis meníngea
- c) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
- d) Encefalopatía de Wernicke
- e) Encefalopatía de Korsakov

37) Un paciente consulta por un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea abundante, asociada a estornudos y malestar general. Además, ha presentado fiebre hasta 38°C, sensación de descarga posterior, hiposmia y obstrucción nasal. El examen físico sólo muestra rinorrea mucosa y eritema faríngeo, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar tratamiento sintomático
- b) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- c) Iniciar amoxicilina oral
- d) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico oral
- e) Solicitar nasofibroscofia

38) Un paciente de 80 años consulta por dolores óseos y astenia. Al examen físico está pálido, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca un hemograma con anemia y plaquetopenia, una creatinina de 2,4 mg/dl y un calcio de 13,6 mg/dl. El frotis de sangre periférica se muestra en la siguiente imagen:



La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de cráneo, electroforesis de proteínas y biopsia de médula ósea
- b) Solicitar radiografía de tórax y biopsia de ganglio linfático
- c) Iniciar prednisona oral y controlar ambulatoriamente
- d) Realizar esplenectomía y solicitar hemograma de control
- e) Observar evolución

39) Una paciente de 30 años presenta constipación de un año de evolución, asociada a flatulencia y distensión abdominal frecuente. Sus deposiciones son caprinas, sin elementos patológicos. No ha presentado otros síntomas. Refiere que su abuela murió de cáncer gástrico hace algunos meses, lo que la tiene preocupada. Su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Intolerancia a la lactosa
- b) Cáncer de colon
- c) Constipación funcional
- d) Pólipo intestinal
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

40) Un paciente de 69 años consulta por dolor abdominal intenso, que ha ido en aumento. Al examen físico está pálido e hipotenso y se palpa una masa pulsátil en el epigastrio, que no se mueve con la inspiración. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica tipo A
- b) Disección aórtica tipo B
- c) Aneurisma aórtico abdominal roto
- d) Infarto miocárdico de pared inferior
- e) Embolia mesentérica

41) Un paciente de 60 años se realiza una TSH como parte de un chequeo médico, que resulta 12 UI/L. Se solicita una nueva TSH, esta vez acompañada de una T4, que resultan 8,5 UI/L y 6,0 ug/dl, respectivamente (VN T4: 4,5 a 12,5 ug/dl). Al examen físico se palpa la glándula tiroides normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles de tiroglobulina
- b) Solicitar ecografía tiroidea
- c) Solicitar anticuerpos TRAB y anti-TPO
- d) Observar evolución
- e) Iniciar levotiroxina oral

TSH ↑
T4 Normal

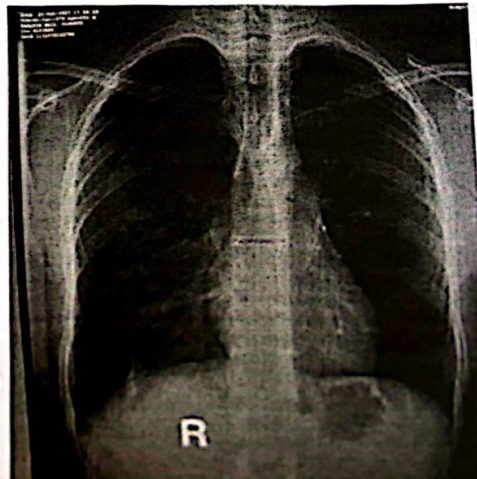
42) Una paciente de 40 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y oliguria. Al examen físico presenta edema de las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes generales que muestran creatinina de 6,5 mg/dl, hematuria dismórfica y normalidad de las pruebas hepáticas y el hemograma. Se solicitan anticuerpos que muestran ANA(-), ANCA(+) en patrón citoplasmático y perfil ENA negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Poliangeítis microscópica
- c) Granulomatosis de Wegener
- d) Síndrome de Churg Strauss
- e) Síndrome de Good Pasture

43) Un paciente de 25 años consulta por dolor torácico derecho intenso, de inicio súbito, que aumenta con la inspiración profunda. Al examen físico se constata asimetría del murmullo pulmonar. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra lo siguiente:

El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumotórax espontáneo
- c) Cuerpo extraño bronquial
- d) Disección aórtica
- e) Neumonía



44) Un paciente es diagnosticado de una meningitis bacteriana aguda, la que es ingresada a la UCI para tratamiento antibiótico y de soporte. Entre sus exámenes destaca elevación de la creatinina hasta 2,5 mg/dl. La conducta más adecuada para el manejo de este hallazgo es:

- a) Realizar biopsia renal
- b) Administrar furosemida endovenosa
- c) Solicitar un TAC abdominal sin contraste
- d) Iniciar anticoagulación con heparina
- ☒ e) Administrar suero fisiológico

45) Un paciente de 80 años consulta por astenia. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y se observan algunas petequias en las extremidades inferiores. Se solicita un hemograma que muestra VCM: 100 fl, hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, blancos: 2.600 por mm³, 60% linfocitos, 34% segmentados y 6% monocitos, plaquetas: 43.000 por mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hierro oral y controlar en 6 meses con ferritina
- ☒ b) Iniciar vitamina B12 y folatos por vía oral
- c) Iniciar vitamina B12, folatos y hierro por vía parenteral
- d) Solicitar perfil de hierro y colonoscopia
- e) Derivar para biopsia de médula ósea

46) Un paciente de 50 años, bebedor habitual, diagnosticado de daño hepático crónico hace un año, continúa tomando. Acude a control, donde se observa aumento del perímetro abdominal, con matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica, que mostró líquido ascítico citrino, con 50 células, de predominio polimorfonuclear. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado, además de abandonar el alcohol?

- a) Albúmina endovenosa —
- b) Albúmina intraperitoneal —
- ☒ c) Paracentesis periódicas —
- d) Antibióticos —
- e) Diuréticos —

47) Una paciente de 66 años consulta por anemia. Trae un hemograma, que muestra hematocrito de 24% con Hb: de 8 g/dl, VCM: 68 fl, HCM: 26 pg, plaquetas: 400.000 por mm³, blancos: 11.000 por mm³. El frotis muestra hipocromía, anisocitosis y microcitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☒ a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Alfa-talasemia
- d) Beta-talasemia
- e) Mielodisplasia

48) Una paciente de 43 años consulta por diplopía. Al examen físico presenta proptosis mayor a derecha, asociada a un bocio simple de gran tamaño. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable de hallar en esta paciente?

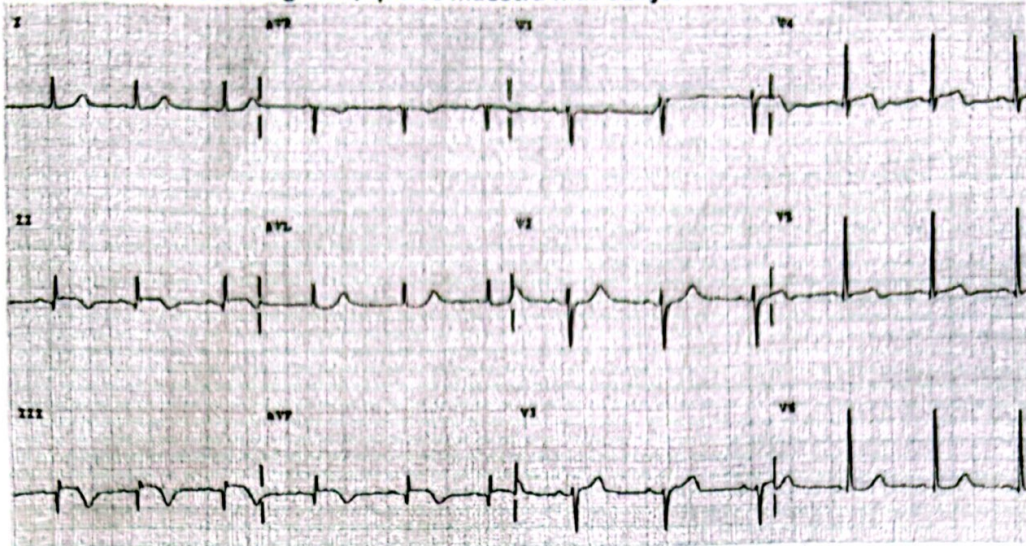
- ☒ a) Positividad de los anticuerpos anti-receptor de TSH
- b) TSH alta
- c) T4 baja
- d) Captación de yodo radiactivo muy disminuida
- e) Macroglosia

TSH ↓
T4 ↑

49) Un niño ha presentado 5 episodios de hemartrosis en las rodillas, ante pequeños traumatismos. ¿Qué examen tendrá alterado con mayor probabilidad?

- a) Recuento de plaquetas
- ☒ b) Pruebas de agregación plaquetaria
- c) Tiempo de protrombina
- d) Tiempo de tromboplastina parcial activado
- e) Tiempo de sangría

50) Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, consulta por disnea de esfuerzos, de 6 meses de evolución, que ha ido en aumento. Refiere que duerme con 2 a 3 almohadas, porque de lo contrario despierta algo ahogado en la noche. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra más abajo.



- ☒ a) Cardiopatía hipertensiva
- b) Cardiopatía coronaria
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Miocardiopatía dilatada
- e) Miocardiopatía restrictiva

51) Un paciente de 69 años presenta deterioro cognitivo, con alteraciones de la memoria reciente, asociado a caídas, rigidez y movimientos de tipo extrapiramidales. Además, tiene alucinaciones visuales complejas con cierta frecuencia. No presenta focalidad neurológica y es capaz de invertir series. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia de Alzheimer
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Demencia frontotemporal
- ☒ d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Delirium

52) Un paciente de 80 años acude a control de sus patologías crónicas. Tiene antecedente de un infarto hace 10 años, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con metformina, hidroclorotiazida, levotiroxina, atorvastatina y aspirina. Entre sus exámenes destaca HbA1c: 7,5%, controles de presiones arteriales con valores promedio de 146/88 mmHg, TSH: 5,0 UI/L y perfil lipídico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☒ a) Subir la dosis de metformina
- b) Subir la dosis de hidroclorotiazida
- c) Subir la dosis de levotiroxina
- d) Reemplazar la metformina y la hidroclorotiazida, por sitagliptina y enalapril
- e) Mantener indicaciones

53) Un paciente de 60 años, que fuma una cajetilla al día, presenta un cuadro de tos con expectoración, de un mes de evolución, asociado a disnea ocasional. Además, ha presentado hemoptisis en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- ☒ a) Bronquiectasias
- b) Bronquitis crónica
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Cáncer bronquial
- e) Neumonía por Haemophilus influenzae

54) Un paciente de 54 años está hospitalizado por un cuadro de podagra izquierda, que fue manejado exitosamente con AINEs endovenosos. Pocos meses antes había presentado el mismo cuadro, también en la primera articulación metatarsofalángica izquierda. Actualmente está en buenas condiciones y se ha decidido darlo de alta. Su uricemia plasmática es de 10,5 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

- a) Enviar a domicilio con hidroclorotiazida y aumento de la ingesta de agua
- b) Enviar a domicilio con alopurinol e hidroclorotiazida oral, más dieta
- c) Enviar a domicilio con dieta y aumento de la ingesta de agua
- d) Enviar a domicilio con alopurinol, probenecid y furosemida
- ☒ e) Enviar a domicilio con alopurinol oral e insistir en el cumplimiento de la dieta

55) Un paciente de 54 años, cirrótico por consumo de alcohol, presenta deterioro del estado general y desorientación. Al examen físico está en sopor superficial, desorientado, con signos de ascitis y fiebre hasta 38°C. La palpación abdominal es dolorosa, pero sin signos peritoneales. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen
- b) Realizar paracentesis diagnóstica y solicitar hemograma, pruebas hepáticas y estudio de líquido ascítico
- ☒ c) Solicitar relación GOT/GPT e iniciar corticoides endovenosos
- d) Resolver quirúrgicamente
- e) Solicitar colangiografía

56) Un paciente de 60 años consulta por desviación de la comisura labial, de inicio súbito, hace algunas horas. Al examen presenta imposibilidad de sonreír y arrugar el mentón con el lado derecho de la cara, asociado a debilidad de los músculos masticatorios del mismo lado. Puede fruncir el ceño y arrugar la frente, de ambos lados, con normalidad. El diagnóstico más probable es:

- ☒ a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Cefalea cluster
- c) Síndrome de Ramsey Hunt
- d) Parálisis de Bell
- e) Parálisis facial central

57) Una paciente de 69 años, asintomática, se realiza exámenes de control, que muestran un hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,5 g/dl, plaquetas: 80.000 por mm³, glóbulos blancos: 26.800 por mm³, linfocitos: 85%, monocitos: 2%, neutrófilos: 12%, eosinófilos: 1%. Su examen físico muestra palidez, sin mayores alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección viral
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Mieloma múltiple
- d) Leucemia linfática aguda
- ☒ e) Mielodisplasia

58) Un paciente de 68 años, fumador de 30 paquetes-año consulta por malestar general y tos con expectoración, la que suele ser hemoptoica. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un nódulo pulmonar de 4,5 cm de diámetro, el que se confirma con el TAC, ubicado en el lóbulo superior izquierdo, sin adenopatías asociadas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar broncoscopia
- ☒ b) Solicitar RMN de tórax
- c) Solicitar angioTAC de tórax
- d) Iniciar clindamicina endovenosa
- e) Realizar lobectomía pulmonar superior izquierda

59) Un paciente de 70 años presenta temblor de las extremidades superiores, algo mayor en el lado derecho. El temblor aumenta al adoptar una postura o al tomar un objeto. Su marcha es normal y es capaz de coordinar normalmente sus movimientos. No presenta disminución de la fuerza de dichas extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Síndrome cerebeloso
- ☒ c) Temblor esencial
- d) Corea de Huntington
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

60) Una paciente puerpera de 24 horas, cuyo parto fue por cesárea, presenta disnea de manera súbita, la que se acompaña de dolor torácico que le impide respirar profundamente. El examen físico muestra taquipnea de 35x', sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de tórax
- ☒ b) Solicitar angioTAC de tórax
- c) Solicitar ecocardiograma transesofágico
- d) Solicitar dímero
- e) Solicitar electrocardiograma

61) Paciente que acude a control ambulatorio con antecedentes de infarto al miocardio anteroseptal con perfusión adecuada hace dos semanas, actualmente, asintomático cardiovascular. Se controla ECG que destaca supradesnivel en pared anterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Aneurisma ventricular
- ☒ b) Insuficiencia mitral isquémica
- c) Isquemia persistente
- d) Necrosis transmural
- e) Pericarditis postinfarto

62) Un paciente cursando una neumonía grave, presenta los siguientes gases arteriales: PaO₂: 55 mmHg, PaCO₂: 28 mmHg, HCO₃: 13 y pH: 7,29. El diagnóstico gasométrico es:

- ☒ a) Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria
- b) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria
- c) Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica
- d) Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica
- e) Error de la muestra, con toma de gases venosos

63) Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de astenia y malestar general. Se solicitan exámenes que muestran calcemia: 14,8 mg/dl, albúmina plasmática: 3,6 g/dl, PTH: disminuida, fosfatasas alcalinas: elevadas. El diagnóstico más probable es:

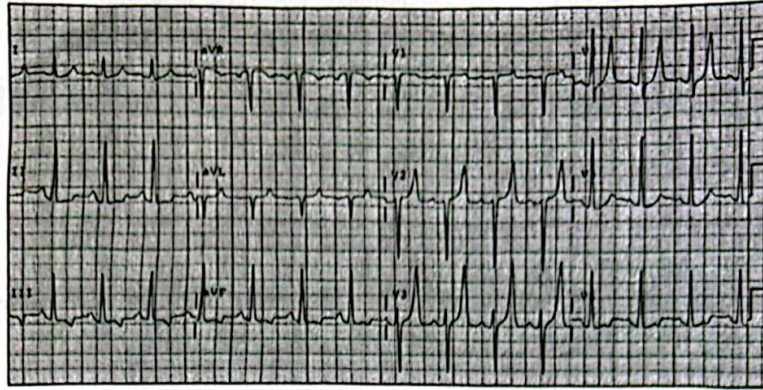
- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Cáncer medular de tiroides
- ☒ c) Hipercalcemia maligna
- d) Hipercalcemia ficticia
- e) Insuficiencia suprarrenal

64) Un paciente de 3 años presenta un cuadro de esteatorrea y baja de peso, asociada a signos carenciales (caída de cabello, queilitis angular, piel seca). Se realiza un test de Sudán III, que resulta positivo y un test de la D-xilosa, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

- ☒ a) Déficit de páncreas exocrino
- b) Enfermedad celíaca
- c) Giardiasis intestinal
- d) Síndrome de intestino corto
- e) Diarrea crónica inespecífica

65) Un paciente insuficiente renal crónico terminal está una semana sin ir a dializarse, evolucionando con debilidad generalizada y marcado compromiso del estado general. Su electrocardiograma muestra lo siguiente:

- a) Hipokalemia
- b) Hiponatremia
- c) Hipercalemia
- d) Hiperkalemia
- e) Hipocalcemia



66) Un paciente de 40 años, sin antecedentes ni hábitos de importancia, hace 2 años sufre una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, la que fue tratada con antibióticos, con buena respuesta. Sin embargo, evoluciona posteriormente con broncorrea crónica, mayor en las mañanas, que en ocasiones viene acompañada de expectoración hemoptoica. El diagnóstico más probable es:

- a) Cuerpo extraño bronquial
- b) Tuberculosis
- c) Cáncer pulmonar
- d) Bronquitis crónica
- e) Bronquiectasias

67) Un paciente presenta estrabismo convergente, con imposibilidad de mirar hacia la derecha con el ojo derecho. El resto de los movimientos oculares están conservados. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del tercer nervio craneal
- b) Lesión del cuarto nervio craneal
- c) Lesión del sexto nervio craneal
- d) Lesión del séptimo nervio craneal
- e) Lesión del fascículo longitudinal medial

68) Un paciente de 44 años presenta dolor abdominal epigástrico intenso, constante, de 24 horas de evolución, asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades. Se aprecia muy adolorido, sudoroso, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión. Se observa un área de equimosis periumbilical. El abdomen es blando, doloroso a la palpación, con signos de irritación peritoneal y disminución marcada de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia mesentérica
- b) Trombosis de vena mesentérica
- c) Estallido hepático
- d) Perforación de úlcera péptica
- e) Pancreatitis aguda

69) Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, de larga data, con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida consulta por dolor intenso de la extremidad inferior izquierda, de tipo neurálgico, que recorre el dermatoma L4. Al examen físico se observa enflaquecido, con disminución de la sensibilidad distal y sin alteraciones motoras. La hemoglobina glicosilada resulta 9,9%. La conducta más adecuada es:

- a) Reforzar el tratamiento con hipoglicemiantes orales y controlar en 3 meses
- b) Suspender la glibenclamida y agregar insulina NPH nocturna
- c) Indicar zapatos adecuados y revisión diaria de los pies y regularizar el tratamiento con hipoglicemiantes orales
- d) Indicar un plan de ejercicios, reforzar la adhesión al tratamiento y controlar en 7 días
- e) Hospitalizar, iniciar insulino terapia y venlafaxina oral

70) Un paciente de 45 años, hipertenso, consulta por palpitaciones de inicio súbito de una hora de evolución. Al examen está en buenas condiciones generales, con pulso de 80 lpm, irregular y presión arterial 120/80 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que muestra una fibrilación auricular. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico de urgencia
- b) Realizar cardioversión eléctrica de inmediato
- c) Realizar masaje carotideo
- d) Administrar verapamilo endovenoso
- e) Realizar cardioversión farmacológica con propafenona